

HoLEP (홀뮴 레이저 적출술)

WARWIKI

환자 안내문 · 크기에 상관없이 비대해진 전립선에 시행하는 레이저 수술

홀뮴 레이저 전립선 적출술(HoLEP)은 전립선비대증(BPH)에 시행하는 레이저 수술로, 내시경을 통해 내부 폐색 조직을 제거합니다 — 외부 절개가 없습니다. 가장 큰 장점은 전립선 크기에 상관없이 적용 가능하다는 것입니다. 과거에는 개복 수술이 필요했던 매우 큰 전립선도 치료할 수 있으며, 출혈이 적고 효과가 오래 지속됩니다.

이 수술에 대하여

요도에 삽입한 내시경을 통해 **홀뮴 레이저**로 전립선 내부(폐색 원인 부위) 전체를 외피에서 분리합니다 — 과일 껍질에서 과육을 분리하는 방식과 같습니다. 분리된 조직은 방광으로 밀어 넣은 뒤 잘게 분쇄하여(**분쇄술**) 제거합니다. 폐색 조직 전체를 제거하므로 효과가 **오래 지속**되고 재치료가 드뭅니다.

HoLEP을 선택하는 이유

- 매우 큰 경우를 포함하여 **전립선 크기에 상관없이** 적용 가능합니다
- **출혈이 적어** — 혈액 희석제를 복용하는 분도 대부분 시행 가능합니다
- 도뇨관 유지 기간이 짧고 효과가 오래 지속됩니다

전문적인 술기가 필요하므로 경험 많은 집도의에게 받을 때 최선의 결과를 기대할 수 있습니다.

용어 설명

HoLEP

홀뮴 레이저를 이용한 전립선 내부 조직 전체 적출술.

BPH

전립선비대증 — 전립선이 양성으로 커진 상태.

적출

전립선 내부 조직 전체를 외피에서 분리·제거하는 것.

홀뮴 레이저

조직을 분리하고 출혈을 최소화하며 봉합하는 레이저.

분쇄술

방광 내로 밀어낸 조직을 잘게 분쇄하여 제거하는 과정.

역행성 사정

건식 오르가슴 — 흔하게 나타나는 무해한 후유증.

수술 후 어떤 변화가 생기나요? 대부분의 환자는 강하고 지속적인 요류를 회복합니다. 다른 전립선 수술과 마찬가지로 **역행성 사정**(건식 오르가슴)이 흔하게 나타납니다. 초기 몇 주 동안 일시적인 절박뇨나 가벼운 요실금이 있을 수 있으나 거의 대부분 회복됩니다. 발기에 지속적인 영향이 생기거나 요실금이 장기간 지속되는 경우는 드뭅니다.

준비 방법

- 전신마취 또는 척추마취로 진행됩니다 — 금식 및 복용 중인 약에 관한 지시사항을 따르세요.
- 수술 전 감염 여부 확인을 위한 **소변 검사**가 필요합니다.
- 귀가를 도와줄 사람을 미리 준비하고, 단기간 도뇨관 유지를 예상하세요.

진행 과정 & 후

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 레이저로 전립선 내부 조직을 적출한 뒤 분쇄하여 제거합니다.
- 3 도뇨관을 유치하며, 보통 **하루 만에** 제거합니다. 당일 퇴원하거나 1박 후 퇴원하는 경우가 많습니다.

수술 후 몇 주간 **혈뇨**와 배뇨 시 약간의 작열감·절박뇨가 있을 수 있습니다. 권고 시 골반저근 운동을 하시고, 힘주기와 무거운 물건 들기는 피하세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 도뇨관 제거 후 **소변을 볼 수 없는** 경우
- 요류를 막는 **심한 출혈 또는 혈전**
- 발열 또는 오한
- 초기 몇 주가 지나도 요실금이 나아지지 않는 경우

기억할 세 가지

1. HoLEP은 레이저로 내시경을 통해 폐색 원인인 전립선 내부 조직 전체를 제거합니다 — **크기에 상관없이** 적용 가능하고 출혈이 적으며 효과가 오래 지속됩니다.
2. 강한 요류를 기대할 수 있으며, 역행성 사정은 흔하고, 초기 절박뇨·요실금은 대부분 회복됩니다.
3. 도뇨관 유지 기간이 짧습니다. 소변을 볼 수 없거나 심한 출혈·발열이 있으면 의료진에게 연락하세요.